

PNEUMOLOGIE

Dr.KHERBA_N

PNEUMOLOGIE

Asthme

BPCO

Bronchite aiguë

Covid_19

Dyspnée

Hémoptysie

PFLA

Pneumothorax

Traumatisme thoracique

Crise d'asthme

● Clinique:

Dyspnée expiratoire + râles sibilants

Affection pulmonaire chronique qui touche les personnes de tous les âges. Elle est causée par l'inflammation et la contracture des muscles autour des voies respiratoires, ce qui rend la respiration plus difficile.

Toux, sifflement, essoufflement, oppression thoracique. Ces symptômes peuvent être légers ou graves et peuvent apparaître et disparaître au fil du temps.

✓ CAT:

- VVP/Scope
- TA/T°/SaO₂/FC/FR
- Position demi assise

- Séance de Nébulisation : 20min

Salbutamol 1cc + 3cc SSI

Solumedrol 40mg en IVD

Ou HHC 200mg en IVD

- Si pas de réponse après 20min

2ème Séance de Nébulisation

- Après 3 séances si pas de réponse ou aggravation:

Chaque 1h => une séance de Nébulisation

+ 0.5mg Atrovant (1cc + 3cc de SSI)

- Si pas de réponse : séance de Nébulisation

+ Sulfate de Mg diluée dans 100cc SG 5%

1g (1amp ou 1/2amp) en 15min

- Si pas de réponse  Avis pneumologie

■ Bilan: 

■ FNS/VS/CRP

■ TLT: Pneumonie

■ Crise modérée: séance de Nébulisation

Salbutamol 1cc + 3cc SSI/6h

+ Solumedrol/8h 40mg

Ou HHC/8h 200mg

■ Si crise sévère ou pause respiratoire  Avis
Réa

Si non Salbutamol en IV

+ Sulfate de Mg en 15min

 Evacuation Réa ou Pneumologie

■ Si fièvre : Perfalgan/8h

Pneumonie : Amoxicilline inj 1g/8h

Ou Augmentin ou Claforan inj/12h

✓ Traitement de fond:

1 Ventoline pour les crises

2 CTC inhalée

+/_ CTC locale=> spray nasal si Rhinite allergique

+/_ AH

1 Ventoline spray 2bouffées 3/j pdt 7j

2 Solupred cp 20mg 1mg/kg 2cp/j 1/j matin au milieu de repas pdt 5j

■ Enfant

■ 3 séances d'aérosol de 20min d'intervalle:
max6

Salbutamol 0.03cc/kg dilués dans 3cc SSI9%

Mini 0.03 Max 1cc si >30kg

■ Si pas de réponse :

+/- inj Solumedrol 2mg/kg en IM

Mini 20mg Max 60mg

✓ Traitement de sortie :

1 Ventoline spray 2bouffées 3/j pdt 7j

Nb des bouffées: Poids/2 chaque 6h

2 Celestene 10gtt/kg le matin après repas pdt
5j

Ou Solupred cp 5_20mg 1mg/kg pdt 5j

Ou Physiologne sirop 1ddp 14ml/j en monodose

✓ Traitement de fond: 3mois

- >2ans: Budecort spray 200ug 1bouffée 2/j
- <2ans: Flixotide
- <9mois: Pulmicort 0.5mg

Contrôle → Pédiatre

Décompensation aigue de BPCO

● Clinique :

Exacerbation aigues des symptômes respiratoires : Dyspnée, toux, expectorations (muqueuses), sifflement

Maladie pulmonaire qui réduit le flux d'air et cause des problèmes respiratoires.

✓ CAT :

- Scope/VVP
- SG5% 3l/j + 4_6g de KCl/j
- Bilan : 
- FNS/Gly/CRP
- Urée/Créat
- Ionogramme
- Hémoculture si fièvre

- Gaz du sang avant O2 et 1h après

Après

- ECG

- TLT

- Si suspicion EP=>

Troponine/DDimère/Angioscanner

- O2 thérapie à faible débit 0.5_2l/min

- CTC : Solumedrol 1_2mg/6h en IV

Ou HHC 5mg/kg

- Nébulisation : Salbutamol 5mg + 5cc SSI

Si pas de réponse :

+ Nébulisation 0.25mg Atrovent

1^{ère} h 2 fois puis après amélioration les nébulisations seront espacées/4h

■ Si expectorations purulentes => ATB

Amoxicilline 1g 3/j si allergie => Pyostacine 1g
2/j

Ou Augmentin 1g 3/j

■ Ventilation non invasive

Bronchite aiguë

● Clinique:

Inflammation d'origine infectieuse virale

Toux, fièvre +/- expectorations (purulentes pas=bactérienne c'est le témoignage de nécrose..)

brûlures retrosternales à la toux ou à l'inspiration profonde

Auscultation: Râles bronchiques ou normale

✓ Traitement: symptomatique:

- Antipyrétique et antalgique
- CTC (systémique +/- inhalé), AINS, mycolytiques, expectorants ne sont pas justifiés
- Abstention de tout ATB=> adulte sain

Covid_19

● Clinique :

- Fièvre, Toux, myalgies, dyspnée, perte de goût et odeur, cas similaire..

- FDR (HTA/diabétique/cardiopathie/âgé)

☐ → Hospitalisation

- Pas de FDR=> traitement ambulatoire

4Tests :

- Test rapide antigénique covid_19

- Test RT PCR covid_19

- Sérologie covid_19 IgM et IgG

- TDM thoracique

✓ Traitement de sortie :

1 Augmentin cp 1g 1cp 2/j pdt 10j

Ou Zomax cp 250mg pdt 5j 2cp/j 1^{er} jours puis 1cp/j le reste des 4j

- Vit D amp 2 bte 1^{er} puis 7j après 2^{ème} amp
- Vit C cp 1cp/j le matin
- Zinc cp 10mg 1cp/j
- Mg amp 1amp 2/j

🏠 Hospitalisation :

O2/ATB/CTC/Anticoagulants/Hydroxycloquine

⊖ Pas de CTC avant 7j

- Bilan : 💧
- FNS/Gly/CRP/VS/Urée/Créat
- DDimères
- ASAT/ALAT
- Ionogramme

■ O₂ thérapie 8_10l/min dépend de SaO₂<92%

→ Avis Réa

■ ATB : si fièvre >5j, CRP↑, réapparition de fièvre,
Toux purulent

■ Augmentin inj 1g 3/j pdt 10j

Ou Claforan inj 1g 1g/8h pdt 10j

Ou Ciprolon 200 2/j en perfusion pdt 10j.

■ Anticoagulants : Lovenox si DD>500, IMC>25,
allaité.

IMC<30 : 0.4 / IMC>30 : 0.6 en Sc 1/j pdt 10j

Ou Innohep 3500Ui <30=> 1inj 7500Ui >30=>
2inj

Pdt 10j jusqu'à 1mois si malade sous O₂.

■ Si DD<500 : arrête Lovenox

■ Si DD↑ on ↑la dose si non → Avis Cardiologie

■ Bilan chaque 3_5j : 

■ FNS/CRP/VS

■ Urée/Créat

■ CTC après 7j pdt 5_10j :

Solumedrol 40mg en IV/12h 2/j

Ou Dexaméthasone 4mg amp/j 0.1_0.2mg/kg/j

Ou Solupred 8mg 0.75_1.2mg/kg/j

Sans dépasser 32mg

Dyspnée

● Clinique :

- Difficulté à respirer avec une sensation de gêne ou oppression
- Si cardiopathie : polypnée avec sensation de soif d'air
- FR :
- NN=> 0_28j : 40_60/min
- NRS=> 28j_2ans : 30_60/min
- Enfant < âge de puberté : 22_30/min
- Adulte : 14_22/min

■Étiologies :

■OAP :

Détresse respiratoire brutale, nocturne,
polypnée superficielle rapide, angoisse +/-
douleur, agitation, crépitements bilatéraux

Gravité : hypoTA, cyanose

Dyspnée, Toux ramènent une expectoration
mousseuse blanchâtre..

■Embolie pulmonaire :

Polypnée brutale avec douleur basithoracique
violente, +/- cyanose, syncope..

TVP, alitement prolongé, post op...

Examen clinique cardio pulmonaire normal

■BPCO :

Fumeur, toux avec expectorations, dyspnée pas
améliorée à la position assise

■Asthme :

Terrain atopique, bradypnée expiratoire,
sibilants, nocturne

■Pneumopathies :

Syndrome infectieux, fièvre, syndrome de
condensation parenchymateuse

■Chez un sujet Obèse : نهجة

■Rechercher un diabète :

Signes de résistance à l'insuline

Syndrome d'apnée de sommeil

■Bilan :

■TSH

■Gly à jeûne/HbA1C

■Lipidique

■ Hépatique + Echographie hépatique => à
Rechercher une stéatose hépatique

Classification de la New York Heart Association (NYHA) :

- ☐ Classe I : dyspnée d'effort exclusive pour des efforts inhabituels ; le patient n'éprouve aucune gêne dans la vie courante.
- ☐ Classe II : dyspnée d'effort exclusive pour des efforts importants de la vie courante, comme la marche rapide ou la montée de plus de 2 étages.
- ☐ Classe III : dyspnée d'effort exclusive pour des efforts modestes de la vie courante, comme la marche en terrain plat à vitesse normale.
- ☐ Classe IV : dyspnée permanente, de repos comme d'effort.

Hémoptysie

- Bilan : 
- FNS (plaquettes)
- Rénal

- Bactério : ECBE à rechercher BAAR
- TLT
- Fibroscopie bronchique : confirme le diagnostic
- Angioscanner

-  CAT :
- Repos, position demi assise
- 2VVP/O2 thérapie
- Bilan sanguin

- Surveillance de volume Hémoptysie
- Faible abondance : traitement étiologique et surveillance
- Moyenne ou grande abondance :
Vasoconstricteur en IV
Fibroscopie bronchique ou bronchoscopie

PFLA

● Clinique :

Fièvre, sueur nocturne, douleur thoracique, toux sèche puis purulente, syndrome de condensation et absence des signes ORL, dyspnée..

Auscultation : Râles crépitants

FR>25/min

FC>100/min

■ Radio :

■ Opacité dense, homogène, systématisée, segmentaire ou lobaire, voire atteignant tout un poumon, bronchogramme aérique.

■ Bilan : 

■ FNS : Hyperleucocytose à PNN

■ CRP+++

■ Procalcitonine

■ Si Hospitalisation :

■ Hémoculture

■ ECBU

✓ Traitement :

■ Sans gravité : Amoxicilline 1g 3/j

■ Si non Clarithromycine 500mg 2/j pdt 5_7j

Ou Zeclar 15mg/kg/j 1ddp 2/j pdt 8j

■ Contrôle radio clinique 48_72h

■ Enfant  :

■ Amoxicilline sirop 125/250mg 100mg/kg/j 3/j
pdt 10j

Ou Augmentin 100/250mg 80mg/kg/j 2/j pdt 10j

■ Si non Ceftriaxone 50_100mg/kg/j <2g/j

Ou Erythromycine VO 50mg/kg/j

■ Doliprane 60mg/kg/j

■ Amoxicilline/Augmentin si non Macrolide

 Hospitalisation si <6mois ou sévère

Pneumonie sévère

Détresse respiratoire fébrile

✓ Traitement :

■ Claforan inj 150mg/kg/j 3/j en IVL

Ou Vancomycine 60mg/kg/j 3/j en IVL

Genta inj 5mg/kg/j pdt 3_5j

+/- Flagyl inj 15mg/kg/8h 45mg/kg/j

■ Si jeune : Amoxicilline 3g/j

■ Âgé ou comorbidité : Augmentin



Pneumothorax

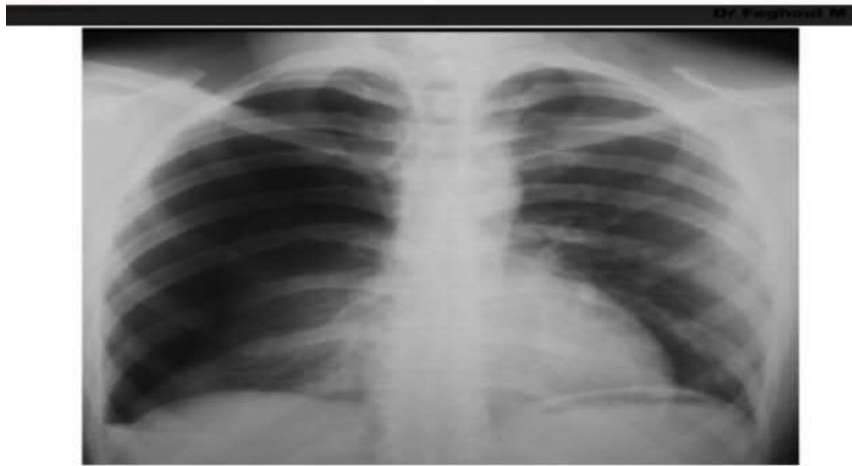
● Clinique :

Douleur brutale, vive, parementée, homolatérale ↗ avec les efforts, dyspnée, polypnée, toux sèche irritative

- Syndrome d'épanchement gazeux :
 - Abolition des vibrations vocales
 - Silence auscultatoire
 - Tympanisme
-
- TLT : hyperclarté périphérique anormal homogène

✓ Traitement :

- Exsufflation à l'aiguille
- Drainage pleural



Traumatisme thoracique

■ Si : Fracture costale 1^{er} et 2^{ème} côte :

- 1 Elastoplast N°5 1app/j
- 2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j
- 3 Voltarene cp 75mg ou Profinid cp 1cp 3/j
- 4 Lomac gel 20mg 1gel 2/j

■ Si : Atteinte musculaire :

- 1 Kefentech patch 1app 2/j
- 2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j

>3côtes=> Admission et surveillance

